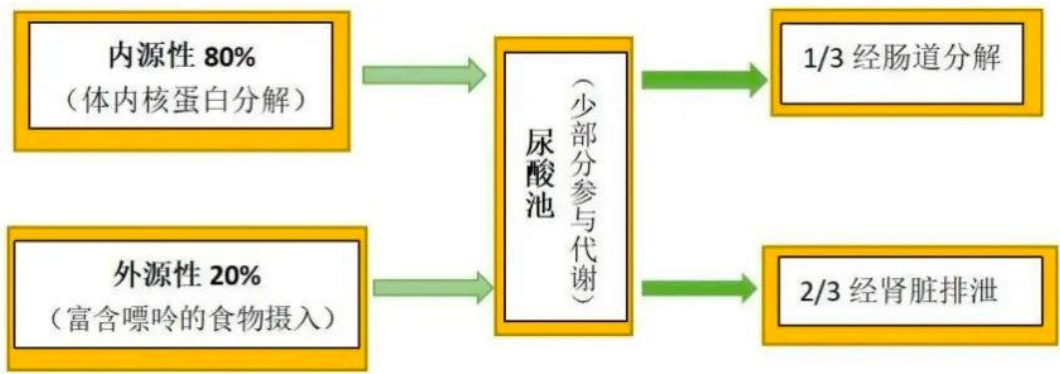


高尿酸、痛风综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

近年来，我国高尿酸血症的患病率持续上升，趋于年轻化，和传统“三高”——高血压、高血脂、高血糖并驾齐驱，成为仅次于糖尿病的第二大代谢疾病。当单钠尿酸盐(MSU)晶体沉积产生炎症性反应时，高尿酸血症进展成为痛风，中国痛风患者数保守估计在 1400 万，严重影响患者的生活质量。



当肠道菌群失衡，菌群紊乱会产生的有害性物质，经肠-肾轴作用，加重肾损伤；肾脏功能受损后，反过来破坏肠道屏障的完整性，让更多有害物质进入血液循环，促炎因子进入血液，加剧肾脏的炎症反应，形成“肠道菌群越紊乱→肾脏负担越重→尿酸代谢越差”的恶性循环，影响尿酸从肾脏排泄效率。另外肠道菌群的失调导致肠道功能受损，同样影响尿酸从肠道的排泄效率。

长期高尿酸血症的危害：尿酸晶体沉积在关节、血管等部位，引起局部炎症反应，从而引起关节、心、脑、肾等多器官损伤，是多种疾病过早死亡的独立预测因子。

一、普筛

1.1 高危人群

中青年男性：男性患高尿酸血症与痛风的高峰期在 40 岁以上的中老年阶段，现在却趋于年轻化。

家族遗传史：相关研究表明，10%~25%的痛风患者存在阳性家族痛风史。痛风患者的近亲有 25%为高尿酸血症。

饮食放纵者：长期从饮食中摄入过多嘌呤，或饮食中的不良因素抑制了尿酸排泄，就可能导致尿酸持续升高，诱使痛风发作。

肥胖人群：脂肪堆积不仅会增加尿酸的生成，脂肪组织还会通过代谢产物影响尿酸排泄。

代谢综合征（胰岛素抵抗）：痛风、高脂血症、高血压病、糖尿病，就互为诱因、互相促进。

经常剧烈运动者：剧烈运动会增加 APT 分解，促进尿酸生成，又会产生大量乳酸，乳酸竞争性抑制肾脏对尿酸的排泄，从而升高血尿酸水平。

1.2 常见症状

夜尿量增多、夜尿次数增多

尿液浑浊，颜色变深

腰疼、排尿困难

关节疼痛

身体水肿

口干口渴

二、试用

嘌呤清：电解质泡腾片溶于水，通过碱化尿液增加尿液中尿酸溶解度达到促排作用，降低体内尿酸水平。每天三次，每次 1 片，不少于 300mL 水中溶解。

三、诊断

高尿酸血症诊断标准：成人在正常嘌呤饮食下非同日 2 次空腹血尿酸 $>420\text{ }\mu\text{mol/L}$ （不分男性、女性）。

分类	诊断标准（ $\mu\text{mol/L}$ ）
轻度高尿酸	$540>\text{尿酸值}>420$
重度高尿酸	尿酸值 ≥ 540
痛风	尿酸值 >420 ，且痛风性关节炎发作不少于 1 次/年

四、干预治疗

治疗的总体目标是促进晶体溶解和防止晶体形成、控制症状，合理的综合治疗能提高其生命质量，减少并发症的发生，改善预后。

改善生活方式是治疗痛风及高尿酸血症的核心。对于部分早期发现的患者，可尝试单纯的生活方式干预。

高尿酸血症无合并症人群降尿酸目标为血尿酸 $<420\text{ }\mu\text{mol/L}$ ，并长期维持；

高尿酸血症有合并症人群降尿酸目标为血尿酸 $<360\text{ }\mu\text{mol/L}$ ，并长期维持；

痛风患者降尿酸治疗目标为血尿酸 $<360\text{ }\mu\text{mol/L}$ ，并长期维持；

若患者已出现痛风石、慢性痛风性关节炎或痛风性关节炎频繁

发作，降尿酸治疗目标为血尿酸 $<300\text{ }\mu\text{ mol/L}$ ，直至痛风石完全溶解且关节炎频繁发作症状改善，可将治疗目标改为血尿酸 $<360\text{ }\mu\text{ mol/L}$ ，并长期维持。因人体中正常范围的尿酸有其重要的生理功能，血尿酸过低可能增加阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的风险。因此建议，降尿酸治疗时血尿酸不低于 $180\text{ }\mu\text{ mol/L}$ 。

名称	作用机理
清畅/畅快	调节肠道菌群，恢复肠道功能，抑制炎症反应。
纽畅 B	抗氧化应激，修复细胞损伤，恢复肝肾功能。
嘌立清	碱化尿液，促进尿酸排出。
降尿酸干预产品	碱化尿液，促进尿酸排出；抑制黄嘌呤氧化酶作用，减少尿酸生成。

分类	干预方案
轻度高尿酸	清畅/畅快：早餐前 1 袋 嘌立清：一天三次，每次一片溶于不少于 300mL 水
重度高尿酸	清畅/畅快：早餐前 1 袋 纽畅 B：晚餐前 1 袋 嘌立清：一天三次，每次一片溶于不少于 300mL 水
痛风	清畅/畅快：早餐前 1 袋 降尿酸产品：午餐前 1 袋 纽畅 B：晚餐前 1 袋

其他干预方式：

加强运动，动起来更健康。每周至少安排 150 分钟的中等强度有氧运动，如快走、慢跑、游泳、骑自行车等。运动能加快身体的新陈代谢，控制体重，尿酸也会跟着降下来。

保证充足水分摄入，多喝水多排尿。每天至少喝 2000—3000 毫升水，足够的水分能让尿酸顺利通过尿液排出体外。

规律作息，睡个好觉很重要。每天保证 7—8 小时的高质量睡眠，早睡早起，别熬夜。经常熬夜会打乱身体的生物钟，影响代谢功能，让尿酸升高。养成规律的作息习惯，身体会越来越健康。

控制体重，让身体“轻装上阵”。把体重指数（BMI）控制在 18.5—23.9kg/m² 范围内。肥胖可是尿酸高的“帮凶”，通过合理饮食和运动，慢慢把体重降下来，尿酸也会变得更稳定。

五、康复管理

名称	干预机制
吸氢气	氢气具有抗炎和抗氧化的作用，它可以减少脂质过氧化物的产生，进而有助于保护肝脏免受氧化应激的损害。此外，氢气还能够促进肝脏细胞再生，加速受损组织的修复过程。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录分析。

高尿酸非药物干预案例记录表

基本信息	姓名		性别	男 ☐ 女 ☐		出生日期	年 月
	身高	cm	体重	kg		BMI	kg/m ²
	电话		地址				
诊疗方案	干预方案	1、_____ 2、_____					开始时间：
		3、_____ 4、_____					调理时长：
	其他建议						
干预前		干预后（_____天）		干预后（_____天）			
尿酸	随机血糖	尿酸	随机血糖	尿酸	随机血糖		
体感变化	干预前			干预后			
肠道变化	☐ 有便秘或腹泻或胃胀等胃肠道不适应症			☐ 有改善 ☐ 没有改善			
关节红肿疼痛	☐ 有关节酸胀、红热、跳痛、僵硬			☐ 有改善 ☐ 没有改善			
排尿异常	☐ 有尿液颜色会变深、变浑浊、有浮沫			☐ 有改善 ☐ 没有改善			
睡觉异常口渴	☐ 有睡觉时会出现口水少、口干和频繁喝水			☐ 有改善 ☐ 没有改善			
身体水肿	☐ 有身体水肿，尤其是下肢明显			☐ 有改善 ☐ 没有改善			
情绪变化	☐ 有疲劳感增加、情绪波动、焦虑、抑郁等			☐ 有改善 ☐ 没有改善			
肾区疼痛	☐ 有后腰部两侧经常隐隐作痛、酸胀不适			☐ 有改善 ☐ 没有改善			
其他内容补充							
评估人/诊所：				评估日期			